

Faits marquants

Le cancer est l'une des principales causes de décès dans le monde, avec près de 10 millions de décès en 2020, soit près d'un décès sur six.

Les cancers les plus courants sont ceux du poumon, du sein, du côlon et du rectum, ainsi que de la prostate.

Près d'un quart des décès par cancer sont dus au tabagisme, à la consommation d'alcool, à un indice de masse corporelle élevé, à une faible consommation de fruits et légumes et au manque d'activité physique. De plus, la pollution atmosphérique est un facteur de risque important pour le cancer du poumon.

Les infections cancérogènes, telles que le papillomavirus humain (HPV) et l'hépatite, sont responsables d'environ 30 % des cas de cancer dans les pays à revenu faible et intermédiaire inférieur.

De nombreux cancers peuvent être guéris s'ils sont détectés à un stade précoce et traités efficacement.

Aperçu

Le cancer est un terme générique désignant un vaste groupe de maladies pouvant toucher n'importe quelle partie du corps. D'autres termes utilisés sont « tumeurs malignes » et « néoplasmes ». L'une des caractéristiques du cancer est la multiplication rapide de cellules anormales qui se développent au-delà de leurs limites habituelles et peuvent ensuite envahir les parties adjacentes du corps et se propager à d'autres organes ; ce dernier processus est appelé « métastase ». Les métastases généralisées sont la principale cause de décès par cancer.

Le problème

Le cancer est l'une des principales causes de décès dans le monde, avec près de 10 millions de décès en 2022 (1). En 2022, les cancers les plus fréquents (en termes de nouveaux cas) étaient les suivants :

le cancer du poumon (2,5 millions de cas)

le cancer du sein (2,3 millions de cas)

le cancer du côlon et du rectum (1,9 million de cas)

le cancer de la prostate (1,5 million de cas)

de la peau (non mélanome) (1,2 million de cas)

de l'estomac (1,0 million de cas).

Les causes les plus fréquentes de décès par cancer en 2022 étaient :

le cancer du poumon (1,82 million de décès)

le cancer du côlon et du rectum (904 000 décès)

le cancer du foie (760 000 décès)

le cancer du sein (666 000 décès)

l'estomac (660 000 décès).

Chaque année, environ 400 000 enfants développent un cancer. Les cancers les plus fréquents varient d'un pays à l'autre, et le cancer du col de l'utérus est le cancer le plus fréquent chez les femmes dans 21 pays, principalement en Afrique subsaharienne.

Causes

Le cancer résulte de la transformation de cellules normales en cellules tumorales au cours d'un processus en plusieurs étapes qui évolue généralement d'une lésion précancéreuse vers une tumeur maligne. Ces modifications sont le résultat de l'interaction entre les facteurs génétiques d'une personne et trois catégories d'agents externes, à savoir :

les agents cancérigènes physiques, tels que les rayons ultraviolets et les rayonnements ionisants ;

les agents cancérigènes chimiques, tels que l'amiante, les composants de la fumée de tabac, l'alcool, l'aflatoxine (un contaminant alimentaire) et l'arsenic (un contaminant de l'eau potable) ; et

les agents cancérigènes biologiques, tels que les infections causées par certains virus, bactéries ou parasites.

L'OMS, par l'intermédiaire de son agence de recherche sur le cancer, le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC), tient à jour une classification des agents cancérigènes.

L'incidence du cancer augmente considérablement avec l'âge, très probablement en raison de l'exposition cumulative à des facteurs de risque qui s'accroissent avec l'âge. L'accumulation globale des risques s'ajoute à la tendance des mécanismes de réparation cellulaire à devenir moins efficaces à mesure que la personne vieillit.

Facteurs de risque

Le tabagisme, la consommation d'alcool, une alimentation malsaine, la sédentarité et la pollution atmosphérique constituent des facteurs de risque de cancer et d'autres maladies non transmissibles.

Certaines infections chroniques sont des facteurs de risque de cancer ; cela pose un problème particulier dans les pays à revenu faible ou intermédiaire. Environ 10 % des cancers diagnostiqués dans le monde en 2022 étaient attribués à des infections cancérigènes, notamment *Helicobacter pylori*, le papillomavirus humain (HPV), le virus de l'hépatite B, le virus de l'hépatite C et le virus d'Epstein-Barr (2).

Les virus de l'hépatite B et C et certains types de HPV augmentent respectivement le risque de cancer du foie et du col de l'utérus. L'infection par le VIH multiplie par six le risque de développer un cancer du col de l'utérus et augmente considérablement le risque de développer certains autres cancers, tels que le sarcome de Kaposi.

Réduire le fardeau

Environ 38 % des cancers peuvent actuellement être évités en évitant les facteurs de risque et en mettant en œuvre les stratégies de prévention existantes fondées sur des données probantes. Le fardeau du cancer peut également être réduit grâce au dépistage précoce du cancer et à la mise en place de traitements et de soins appropriés pour les patients atteints d'un cancer. De nombreux cancers ont de fortes chances d'être guéris s'ils sont diagnostiqués tôt et traités de manière appropriée.

- Prévention
- Le risque de cancer peut être réduit en :
 - ne pas fumer ;
 - maintenir un poids corporel sain ;
 - adopter une alimentation saine, comprenant des fruits et des légumes ;
 - pratiquer une activité physique régulière ;
 - éviter ou réduire la consommation d'alcool ;
 - en se faisant vacciner contre le HPV et l'hépatite B si l'on appartient à un groupe pour lequel la vaccination est recommandée ;
 - en évitant l'exposition aux rayons ultraviolets (qui résulte principalement de l'exposition au soleil et aux appareils de bronzage artificiel) et/ou en utilisant des mesures de protection solaire ;
 - en veillant à une utilisation sûre et appropriée des rayonnements dans les soins de santé (à des fins diagnostiques et thérapeutiques) ;
 - réduire au minimum l'exposition professionnelle aux rayonnements ionisants ;
 - et
 - réduire l'exposition à la pollution atmosphérique extérieure et à la pollution de l'air intérieur, y compris au radon (un gaz radioactif issu de la désintégration naturelle de l'uranium, qui peut s'accumuler dans les bâtiments — habitations, écoles et lieux de travail).
-

Dépistage précoce

La mortalité par cancer diminue lorsque les cas sont détectés et traités à un stade précoce. Le dépistage précoce comporte deux volets : le diagnostic précoce et le dépistage.

Diagnostic précoce

Lorsqu'il est détecté tôt, le cancer a plus de chances de répondre au traitement, ce qui peut se traduire par une meilleure probabilité de survie, une morbidité moindre et

des traitements moins coûteux. La détection précoce du cancer et la prévention des retards dans la prise en charge permettent d'améliorer considérablement la qualité de vie des patients atteints de cancer.

Le diagnostic précoce comporte trois volets :

la connaissance des symptômes des différentes formes de cancer et de l'importance de consulter un médecin lorsque des signes anormaux sont observés ;

l'accès à des services d'évaluation clinique et de diagnostic ; et

l'orientation rapide vers des services de traitement.

Le diagnostic précoce des cancers symptomatiques est pertinent dans tous les contextes et pour la majorité des cancers. Les programmes de lutte contre le cancer devraient être conçus pour réduire les retards et les obstacles au diagnostic, au traitement et aux soins de soutien.

Dépistage

Le dépistage vise à identifier les personnes présentant des signes évocateurs d'un cancer spécifique ou d'une lésion précancéreuse avant l'apparition de symptômes. Lorsque des anomalies sont détectées lors du dépistage, des examens complémentaires doivent être réalisés pour établir un diagnostic définitif, et une prise en charge doit être mise en place si la présence d'un cancer est confirmée.

Les programmes de dépistage sont efficaces pour certains types de cancer, mais pas pour tous, et sont en général bien plus complexes et gourmands en ressources que le diagnostic précoce, car ils nécessitent un équipement spécial et du personnel dédié. Même lorsque des programmes de dépistage sont mis en place, des programmes de diagnostic précoce restent nécessaires pour identifier les cas de cancer survenant chez des personnes qui ne répondent pas aux critères d'âge ou de facteurs de risque requis pour le dépistage.

La sélection des patients pour les programmes de dépistage repose sur l'âge et les facteurs de risque afin d'éviter un nombre excessif de résultats faussement positifs. Voici quelques exemples de méthodes de dépistage :

le test HPV (y compris le test d'ADN et d'ARNm du HPV), en tant que modalité privilégiée pour le dépistage du cancer du col de l'utérus ; et

le dépistage par mammographie du cancer du sein chez les femmes âgées de 50 à 69 ans résidant dans des contextes dotés de systèmes de santé solides ou relativement solides.

Une assurance qualité est requise tant pour les programmes de dépistage que pour les programmes de diagnostic précoce.

Traitement

Un diagnostic correct du cancer est essentiel pour un traitement adapté et efficace, car chaque type de cancer nécessite un protocole thérapeutique spécifique. Le traitement comprend généralement une intervention chirurgicale, une radiothérapie et/ou une thérapie systémique (chimiothérapie, traitements hormonaux, thérapies biologiques ciblées). Le choix approprié d'un protocole thérapeutique tient compte à la fois du cancer et de la personne traitée. Il est important de suivre le protocole thérapeutique dans son intégralité et dans les délais prévus pour obtenir le résultat thérapeutique escompté.

Définir les objectifs du traitement constitue une première étape importante. L'objectif principal est généralement de guérir le cancer ou de prolonger considérablement la vie. L'amélioration de la qualité de vie du patient est également un objectif important. Cela peut être atteint en soutenant le bien-être physique, psychosocial et spirituel du patient et en lui prodiguant des soins palliatifs aux stades terminaux du cancer.

Certains des types de cancer les plus courants, tels que le cancer du sein, le cancer du col de l'utérus, le cancer de la bouche et le cancer colorectal, ont des probabilités de guérison élevées lorsqu'ils sont détectés tôt et traités selon les meilleures pratiques.

Certains types de cancer, tels que le séminome testiculaire et différents types de leucémie et de lymphome chez les enfants, présentent également des taux de guérison élevés si un traitement approprié est administré, même lorsque des cellules cancéreuses sont présentes dans d'autres parties du corps.

On observe toutefois des disparités importantes dans l'accès aux traitements entre les pays selon leur niveau de revenu ; la plupart des pays n'intègrent pas pleinement les services essentiels de prise en charge du cancer – notamment la prévention, le dépistage, le diagnostic, le traitement et les soins palliatifs – dans leurs régimes de santé financés par l'État, ce qui met en évidence des lacunes importantes sur la voie de la couverture sanitaire universelle (3).

Soins palliatifs

Les soins palliatifs consistent à soulager, plutôt qu'à guérir, les symptômes et les souffrances causés par le cancer et à améliorer la qualité de vie des patients et de leurs familles. Les soins palliatifs peuvent aider les personnes à vivre plus confortablement. Ils sont particulièrement nécessaires dans les régions où la proportion de patients atteints d'un cancer à un stade avancé, pour lesquels les chances de guérison sont faibles, est élevée.

Les soins palliatifs permettent de soulager les problèmes physiques, psychosociaux et spirituels chez plus de 90 % des patients atteints d'un cancer à un stade avancé.

Des stratégies de santé publique efficaces, comprenant des soins communautaires et à domicile, sont essentielles pour assurer le soulagement de la douleur et les soins palliatifs aux patients et à leurs familles.

Il est fortement recommandé d'améliorer l'accès à la morphine par voie orale pour le traitement des douleurs cancéreuses modérées à sévères, dont souffrent plus de 80 % des personnes atteintes d'un cancer en phase terminale.

- Réponse de l'OMS
- En 2017, l'Assemblée mondiale de la Santé a adopté la résolution intitulée « Prévention et lutte contre le cancer dans le cadre d'une approche intégrée » (WHA70.12), qui exhorte les gouvernements et l'OMS à accélérer les mesures visant à atteindre les objectifs fixés dans le Plan d'action mondial pour la prévention et la lutte contre les maladies non transmissibles 2013-2020 et dans le Programme de développement durable à l'horizon 2030 des Nations Unies, afin de réduire la mortalité prématurée due au cancer.

- L'OMS et le CIRC collaborent avec d'autres organisations des Nations Unies, notamment l'Agence internationale de l'énergie atomique, ainsi qu'avec des partenaires afin de :
- renforcer l'engagement politique en faveur de la prévention et de la lutte contre le cancer ;
- coordonner et mener des recherches sur les causes du cancer chez l'homme et les mécanismes de la carcinogenèse ;
- surveiller la charge de morbidité liée au cancer (dans le cadre des travaux de l'Initiative mondiale sur les registres du cancer) ;
- identifier les « meilleurs choix » et d'autres stratégies prioritaires et rentables pour la prévention et la lutte contre le cancer ;
- élaborer des normes et des outils pour guider la planification et la mise en œuvre d'interventions en matière de prévention, de diagnostic précoce, de dépistage, de traitement, de soins palliatifs et de suivi des survivants, tant pour les cancers chez les adultes que chez les enfants ;
- renforcer les systèmes de santé aux niveaux national et local afin de les aider à améliorer l'accès aux traitements contre le cancer ;
- définir les priorités en matière de prévention et de lutte contre le cancer dans le Rapport 2020 de l'OMS sur le cancer ;
- assurer un leadership mondial et fournir une assistance technique afin d'aider les gouvernements et leurs partenaires à mettre en place et à pérenniser des programmes de lutte contre le cancer du col de l'utérus de haute qualité, dans le cadre de la Stratégie mondiale visant à accélérer l'élimination du cancer du col de l'utérus ;
- améliorer la lutte contre le cancer du sein et réduire les décès évitables dus à cette maladie, en mettant l'accent sur la promotion de la santé, le diagnostic précoce et l'accès aux soins afin d'accélérer la mise en œuvre coordonnée par le biais de l'Initiative mondiale de l'OMS contre le cancer du sein ;
- aider les gouvernements à améliorer la survie des enfants atteints de cancer grâce à un soutien ciblé aux pays, à des réseaux régionaux et à une action mondiale dans le cadre de l'Initiative mondiale de l'OMS contre le cancer de l'enfant, en utilisant l'approche CureAll ;
- améliorer l'accès aux médicaments essentiels contre le cancer, notamment par le biais de la Plateforme mondiale pour l'accès aux médicaments contre le cancer de l'enfant ; et
- fournir une assistance technique pour un transfert rapide et efficace des interventions fondées sur les meilleures pratiques vers les pays.

